



Cancer du cavum

Professeur Leïla ESSAKALLI HOSSYNI

Chef du service ORL et CCF

Hôpital des Spécialités CHU IBN SINA RABAT

Présidente de la SMORL

essakleila@gmail.com

Introduction

Forme particulière des cancers des VADS

Répartition géographique caractéristique

Relation étroite avec l'EBV

Dominée par l'UCNT:

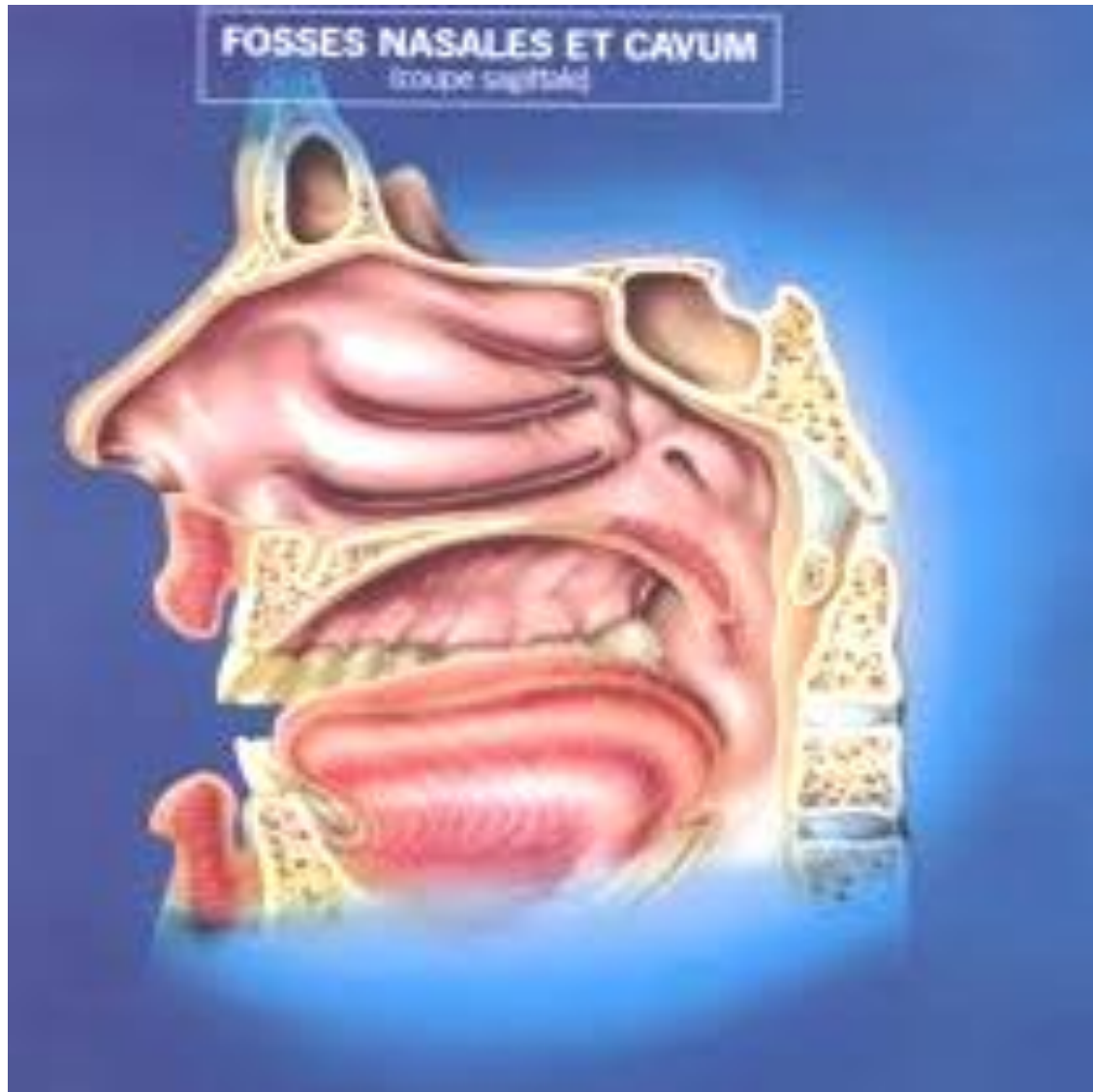
carcinome indifférencié de type nasopharyngien

Syndromes cliniques évocateurs

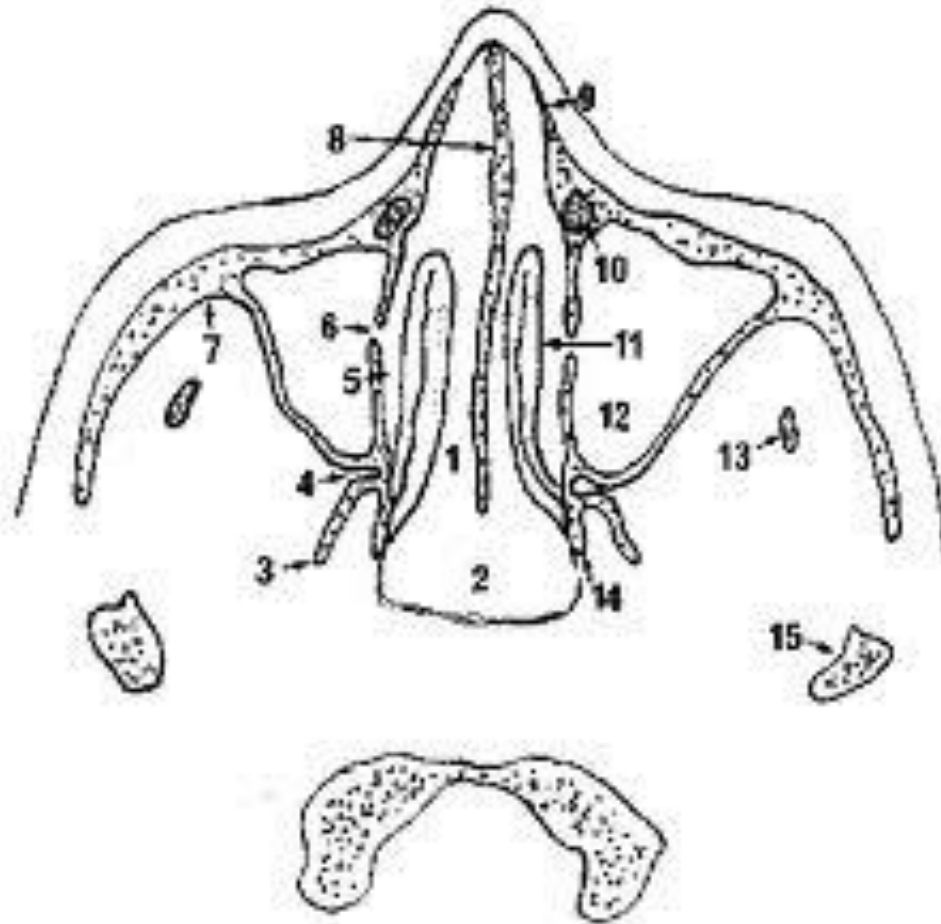
Diagnostic endoscopique et anatomopathologique

Traitement radio-chimiothérapie

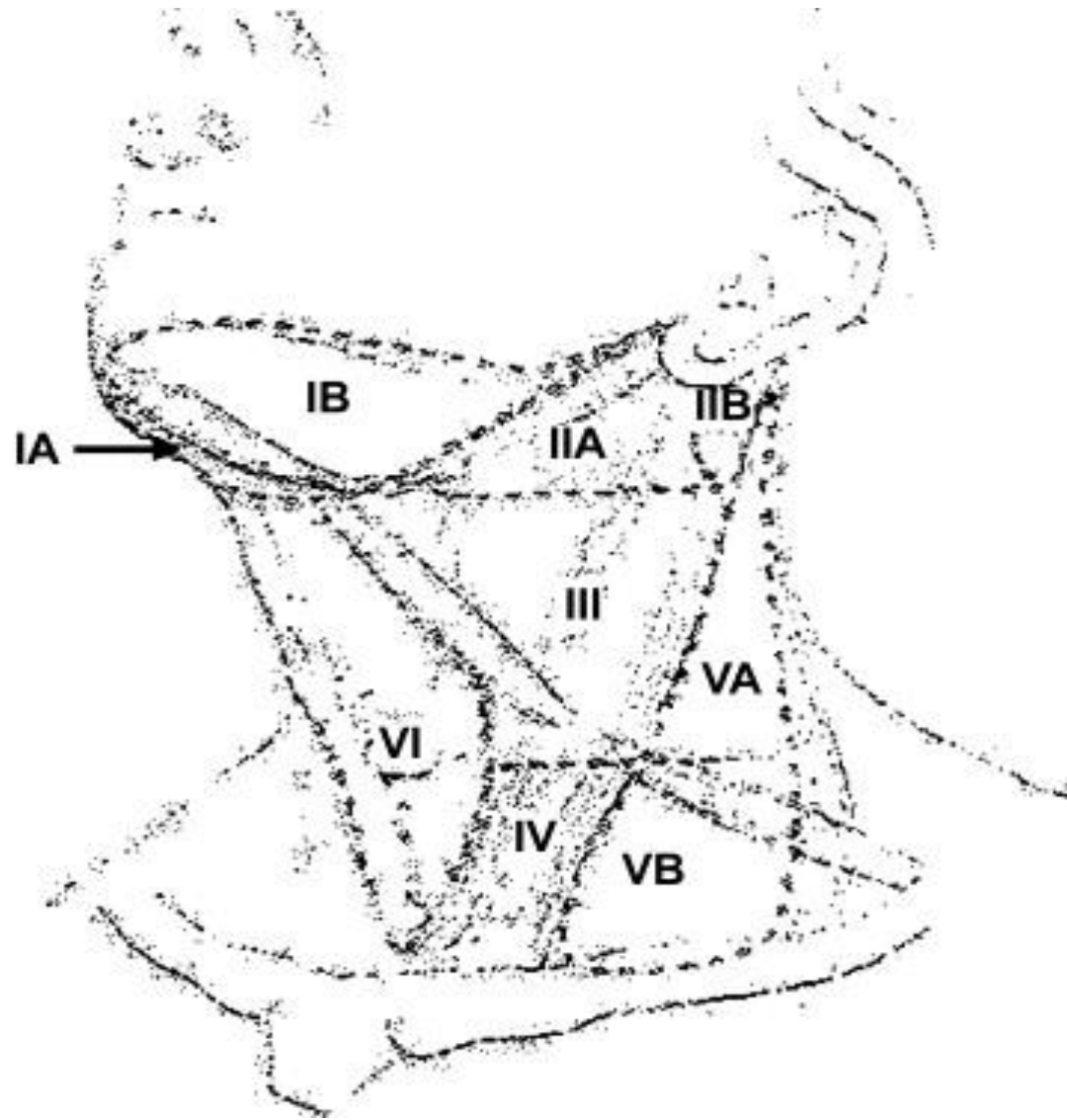
Rappel anatomique



Rappel anatomique



Rappel anatomique



Epidémiologie

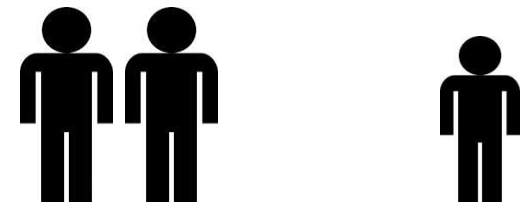
Fréquent dans **l'Asie du sud-est**:
Chine du sud et
dans **les pays du Maghreb**
et du bassin méditerranéen

Au Maghreb, l'incidence est de
15/100000

L'Alaska chez les Esquimaux
L'Europe, les USA et le Japon :
zones **à très faible** risque

2 pics d'âge: 15-20 et
au delà de 45 ans

Sex ratio: 2 hommes/1femme



Etiopathogénie

Plusieurs facteurs retrouvés:

Rôle de l'EBV+++:

- présent dans les cellules tumorales
- Présence d'Ac anti-EBV dans le sang circulant

Facteurs génétiques: formes héréditaires

Facteurs environnementaux:

Nitrosamines

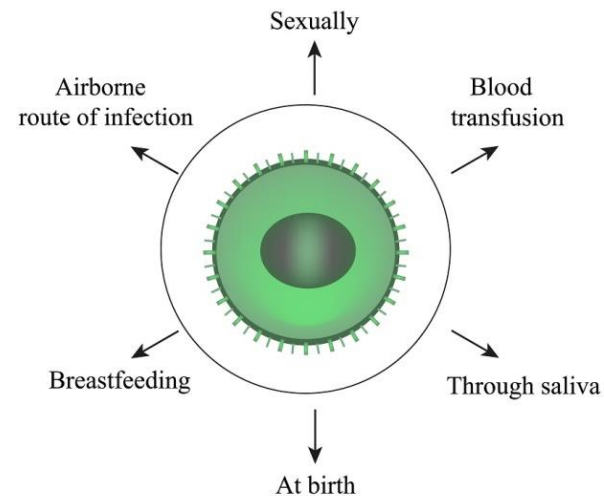
Rôle de l'alcool et du tabac non retrouvé

Intérêt de l'EBV dans le dépistage et la surveillance

Facteurs de risque

- le virus **Epstein Barr** (présence de marqueurs viraux dans les cellules tumorales épithéliales et augmentation du taux d'anticorps anti EBV)

Ways of infection Epstein-Barr virus



Facteurs de risque

- Facteurs **génétiques**

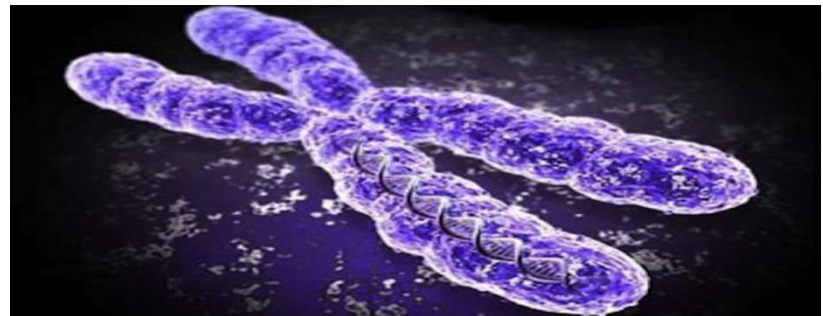
- *3p, 9p, 11q, 13q, 14q et 16q...

- *locus du chromosome 4 et un locus 3p21

- *groupe HLA :B13, A23,

- DRB1*05: Maghreb

- A2, B46, DRB1*03: Asie



Facteurs de risque

- Facteurs alimentaires



Anatomie pathologique

Macroscopie

- Bourgeonnante, ulcéro-bourgeonnante
- Infiltrante
- Sous muqueuse++

Microscopie (classification de l'OMS 2003)

- kc épidermoïde kératinisant (Type I)
- kc épidermoïde non kératinisant :différencié (type II)
- kc indifférencié (type III)
- Adénocarcinome
- Carcinome de type salivaire
- Autres: lymphomes, sarcomes

Anatomie pathologique

Type 1

carcinome
épidermoïde
kératinisant

Type 2

carcinome
épidermoïde non
kératinisant

Type 3

carcinome indifférencié de
type nasopharyngien
(UCNT en anglais) ou
lymphépithéliome

Autres

Lymphome
Rhabdomyosarcome

...

Anatomie pathologique

Les extensions

Locales:

- En haut: Base du crâne et paires crâniennes
- En avant: fosses nasales
- Latérales: trompe auditive et orbite
- En arrière: rachis cervical et étage postérieur de la BDC

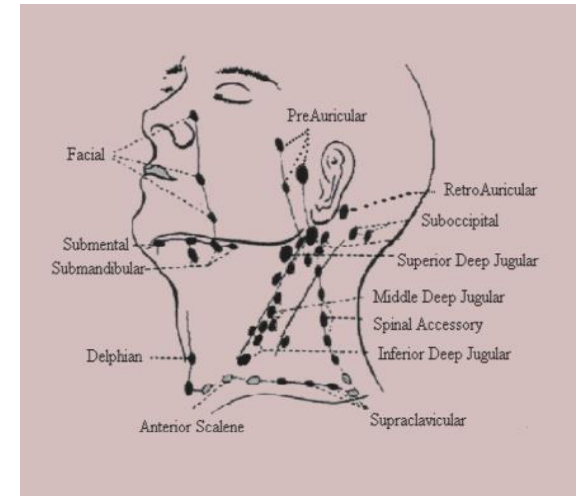
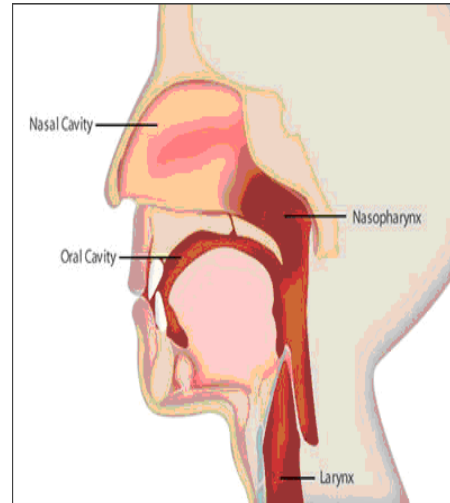
Ganglionnaires:

- Gg rétro-pharyngés ++
- Gg spinaux, sous digastriques
- Gg sus claviculaires

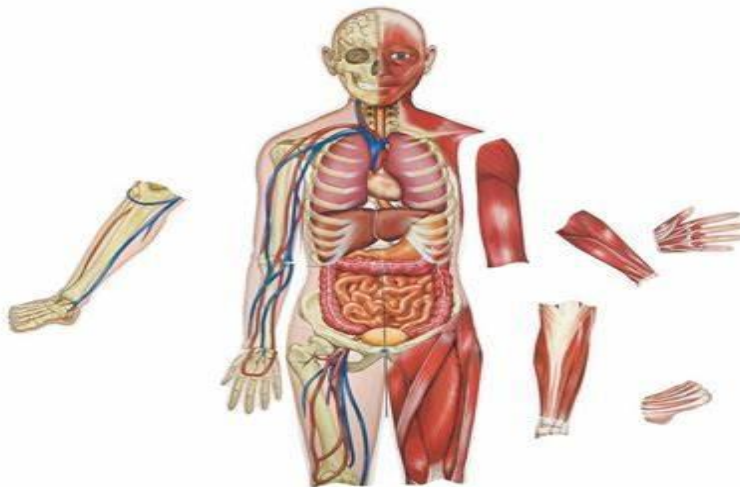
A distance: os, poumon, foie

Extensions

- Locorégionales



- A distance



Diagnostic positif

Latence clinique: retard diagnostique

Symptomatologie regroupée en **syndromes**:

- Sd rhinologique
- Sd otologique
- Sd ganglionnaire
- Sd neurologique

Clinique

- LATENCE
- 4 Syndromes

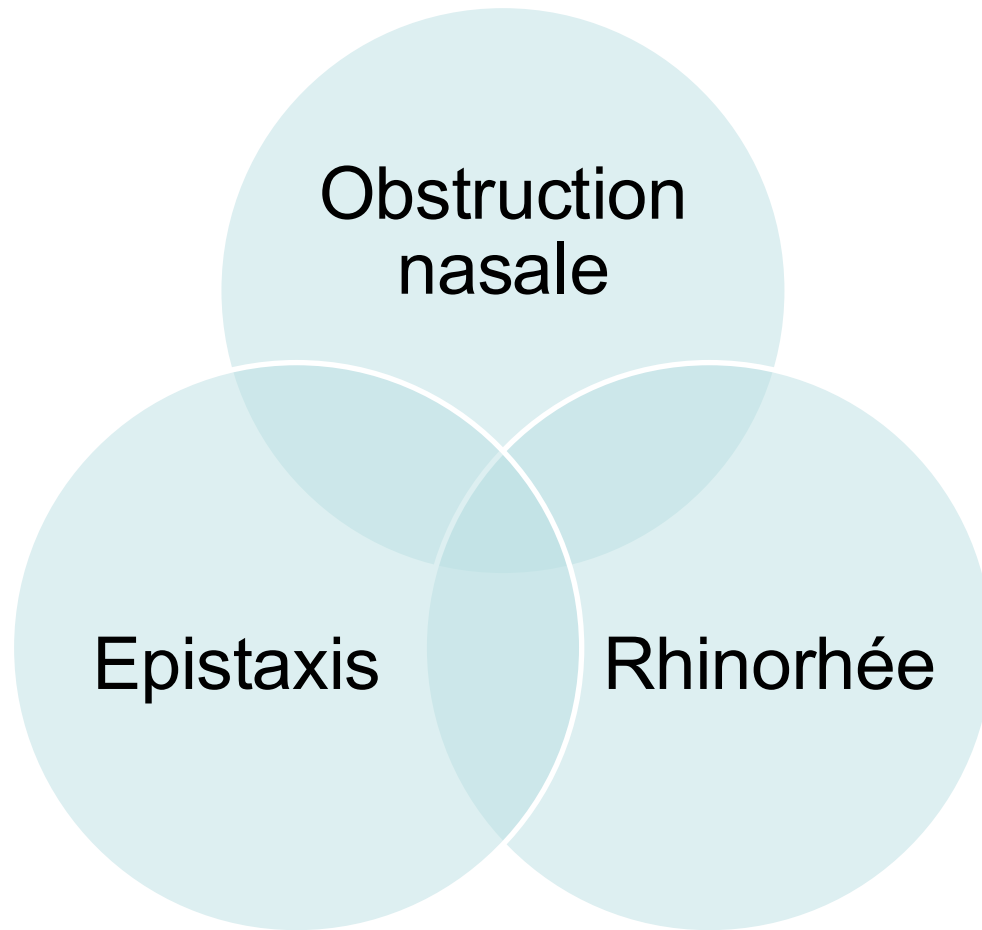
Rhinologique

Otologique

Ganglionnaire

Neurologique

Syndrome rhinologique

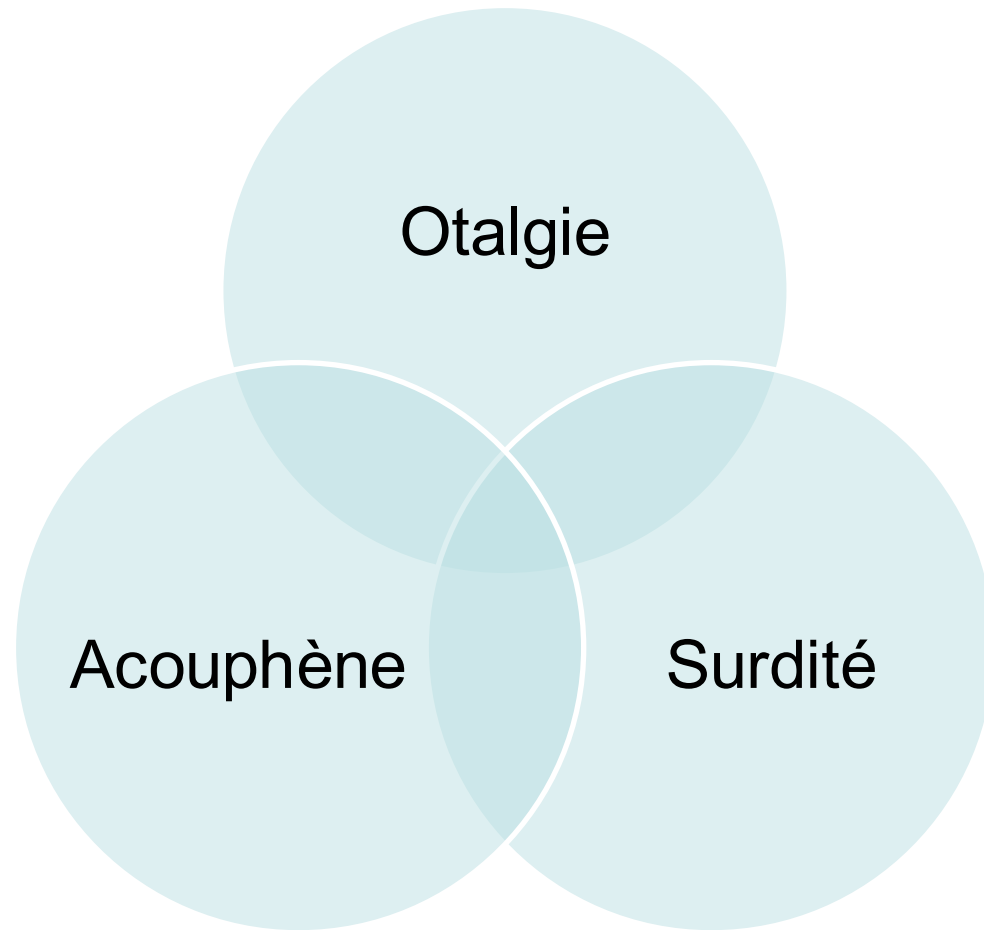


Diagnostic positif

Syndrome rhinologique

- obstruction nasale progressive uni ou bilatérale
- rhinorrhée séro-sanglante
- épistaxis
- Endoscopie nasale ou nasofibroscopie++
- aspect macroscopique de la tumeur
- siège
- réalisation de Biopsies++

Syndrome otologique



Diagnostic positif

Syndrome otologique

- Hypoacousie unilatérale progressive
- Acouphènes
- Autophonie
- Sensation de plénitude de l'oreille

A l'examen otoscopique: OSM , tympan rétracté
ou au contraire un niveau liquide

Acoumétrie: surdité de transmission

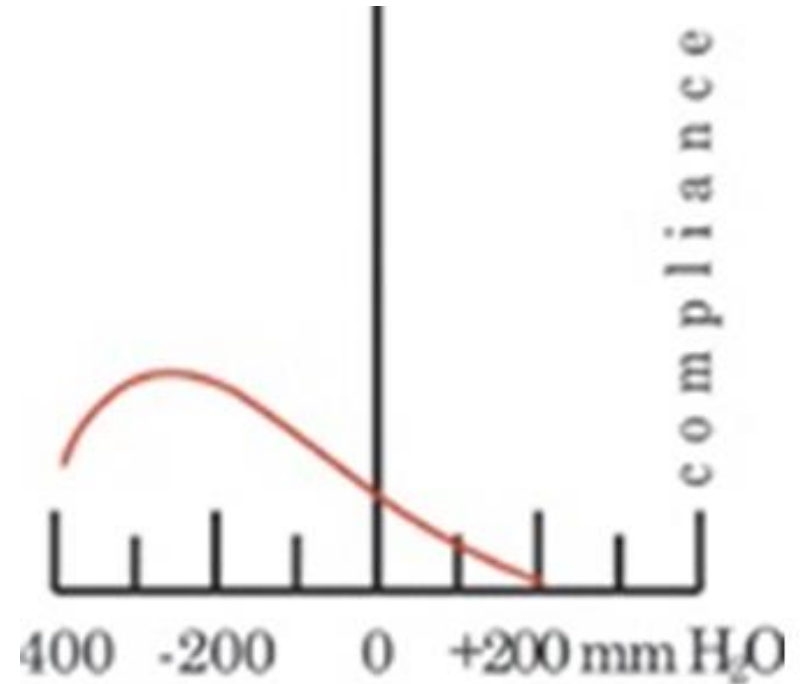
OSM unilatérale → examen cavum systématique

Syndrome otologique

Otoscopie : tympan rétracté



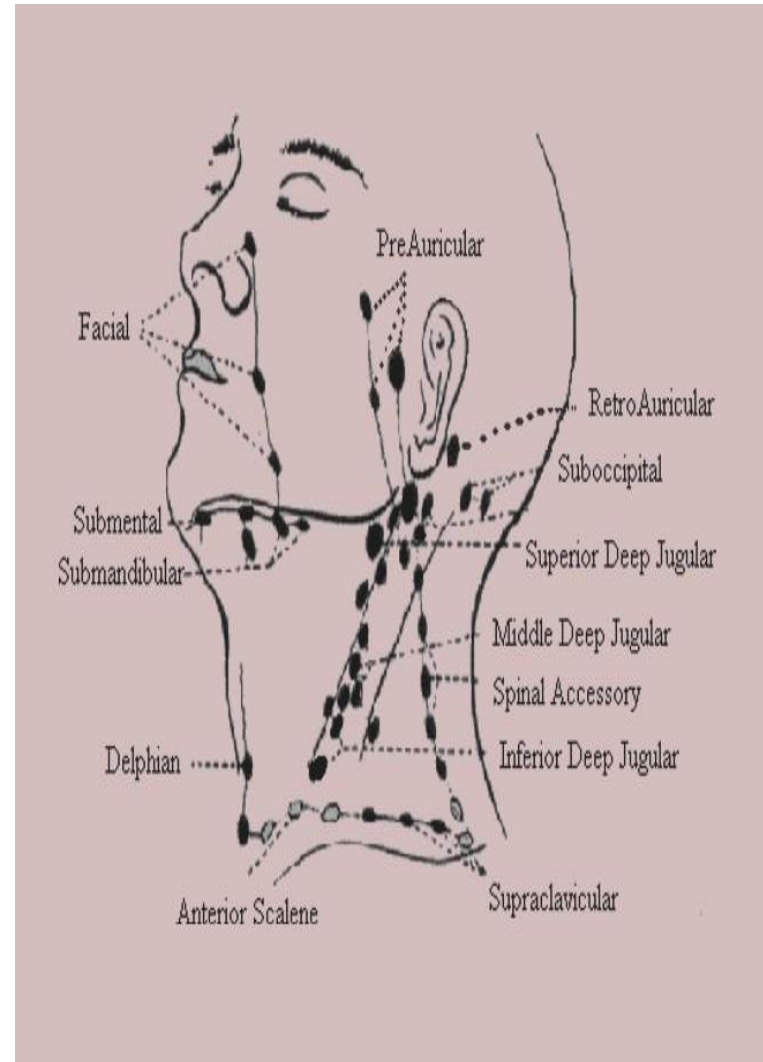
Medecine - 2007



Syndrome ganglionnaire



Schéma daté



Diagnostic positif

Syndrome ganglionnaire

- motif de la première consultation dans 40 % des cas

- L'examen précisera le siège: hautes, bilatérales, occipitales, spinales hautes et basses et

Le caractère mal limité des ADP cervicales

- Schéma daté

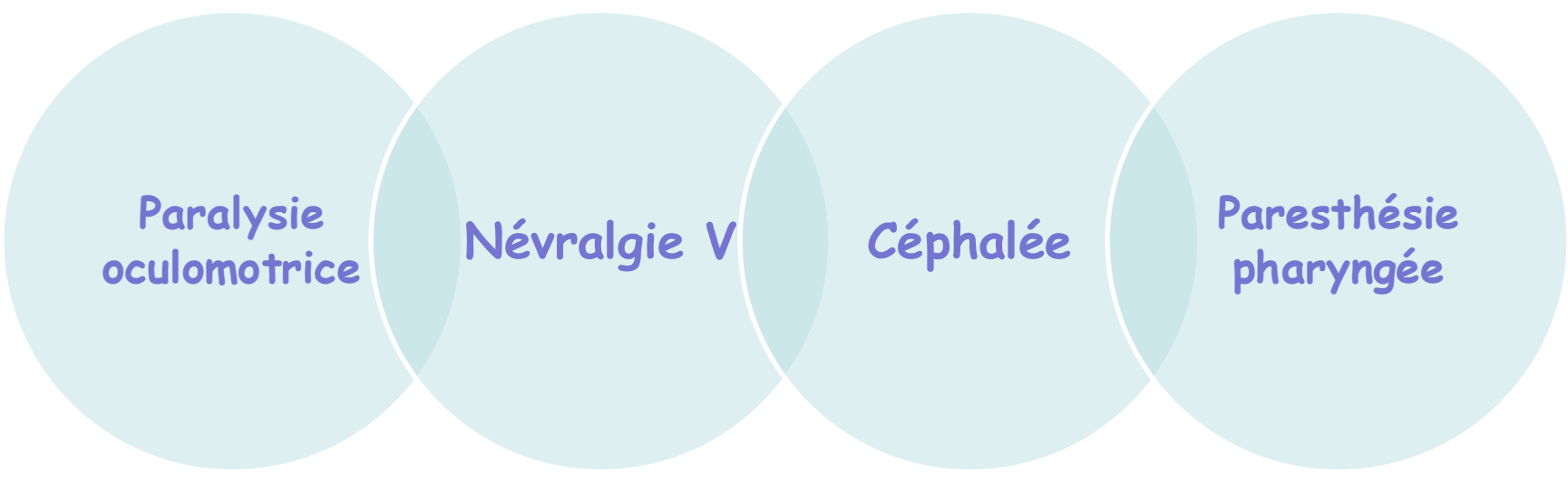
- jamais de biopsie ganglionnaire++

Syndrome ganglionnaire



Schéma daté

Syndrome Neurologique



Paralyse
oculomotrice

Névralgie V

Céphalée

Paresthésie
pharyngée

Diagnostic positif

Syndrome neurologique

- Paralyse oculomotrice
- Paralyse des autres paires crâniennes
- Spasme douloureux de l'hémiface par atteinte du V
- Céphalées

Syndrome neurologique



Bilan lésionnel

- Le diagnostic positif est histologique à la biopsie
- Le bilan lésionnel permettra la classification TNM
- Il comporte:
 - Bilan loco-régional
 - Bilan à distance

Endoscopie nasale et Biopsies



Bilan lésionnel

Bilan loco-régional:

- TDM de la BDC au médiastin supérieur
- IRM de la BDC au médiastin supérieur +++

Bilan à distance:

- TDM thoraco-abdominale
- PET-scan (si disponible)
- Pan endoscopie
- Sérologie EBV
- Bilan hépatique
- Bilan rénal
- Hémogramme

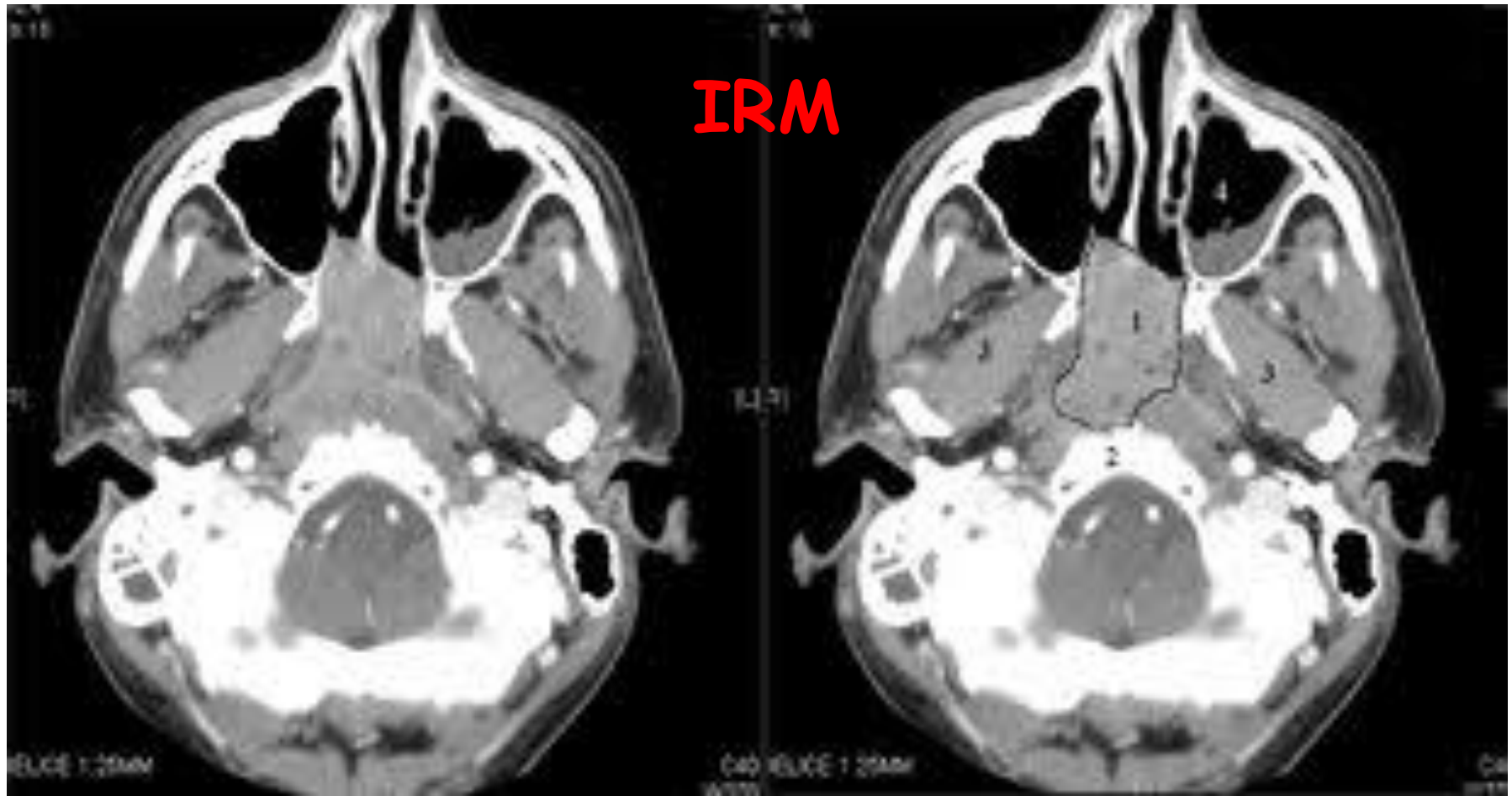
Bilan lésionnel



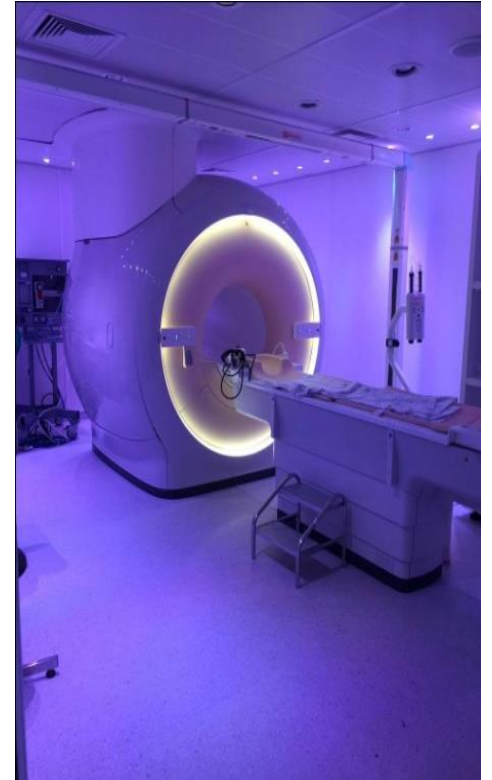
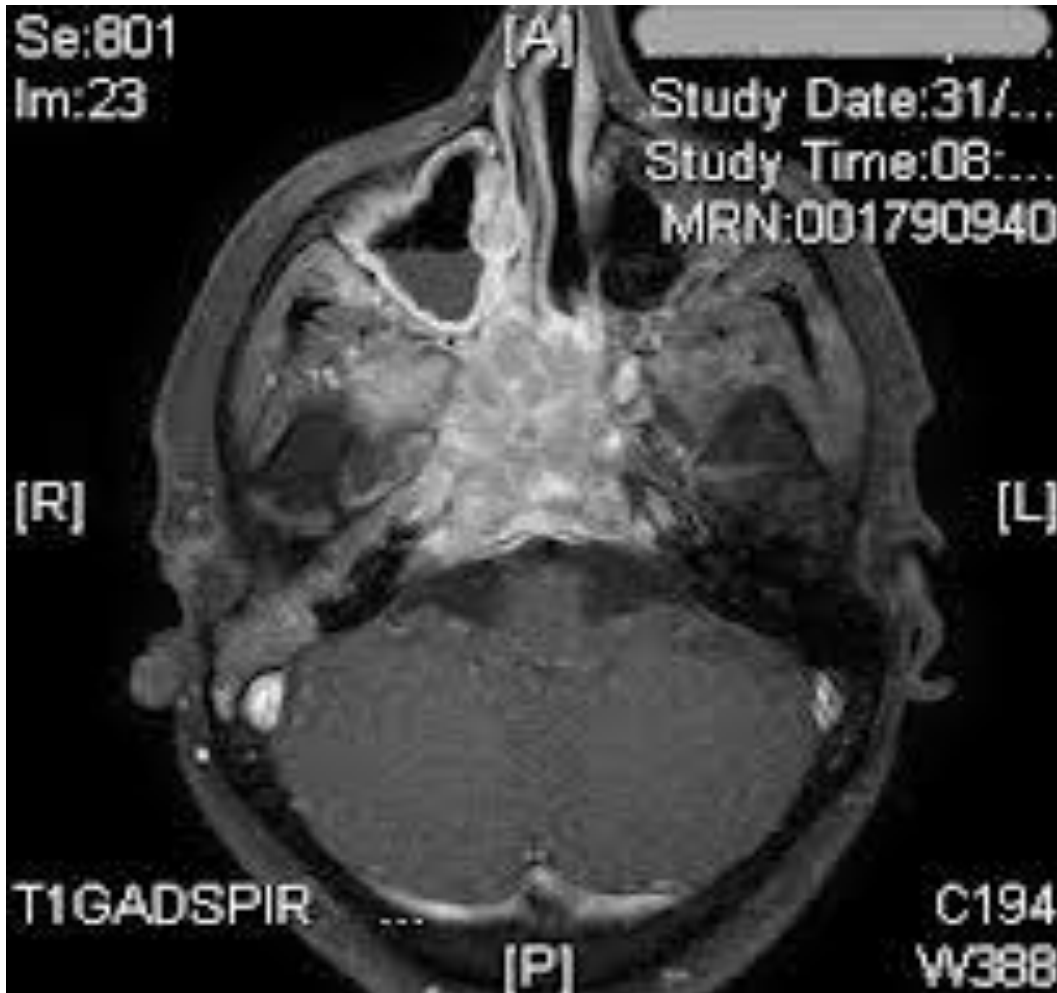
TDM normale



Bilan lésionnel



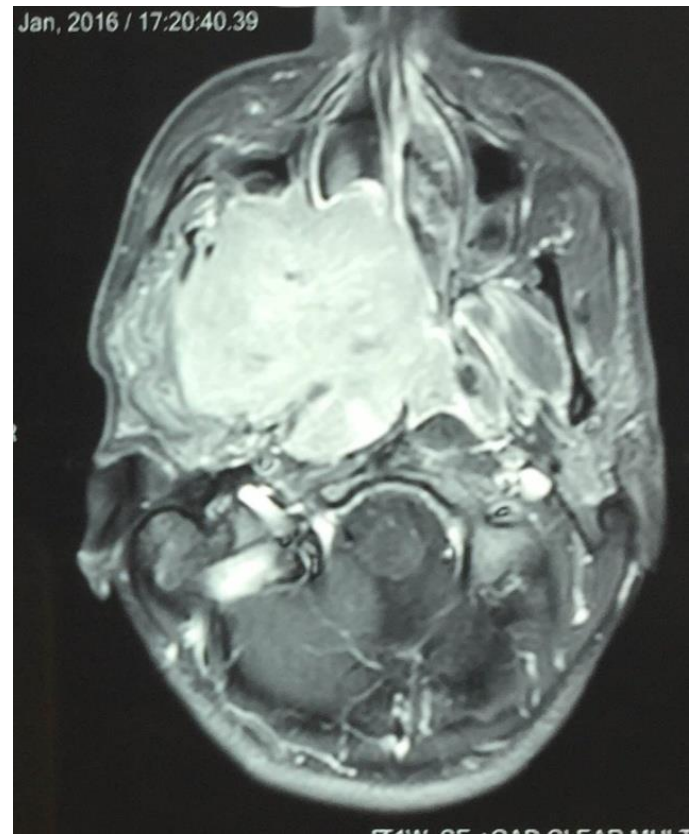
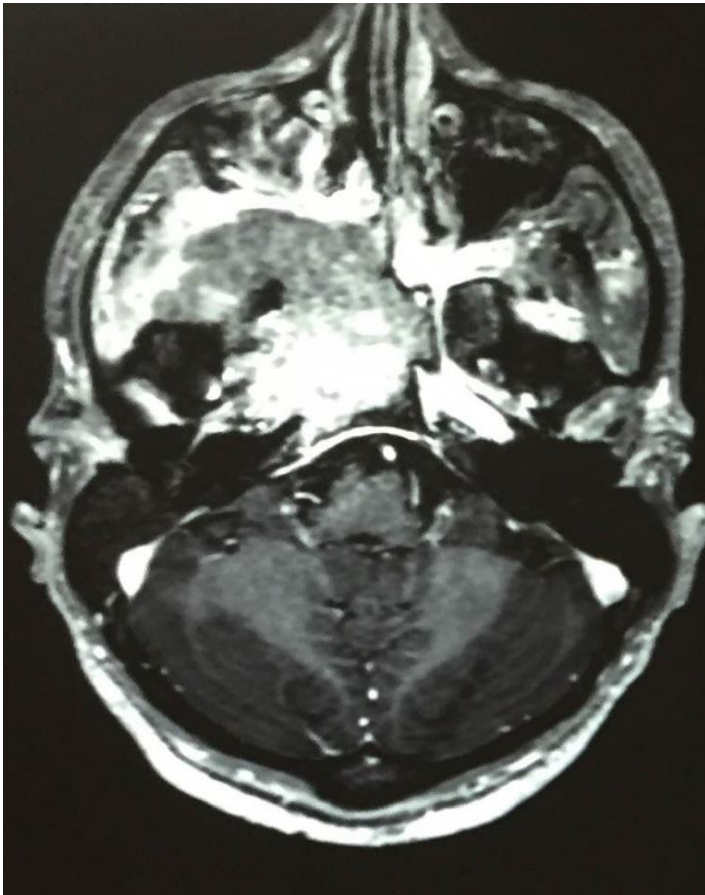
Bilan lésionnel



IRM

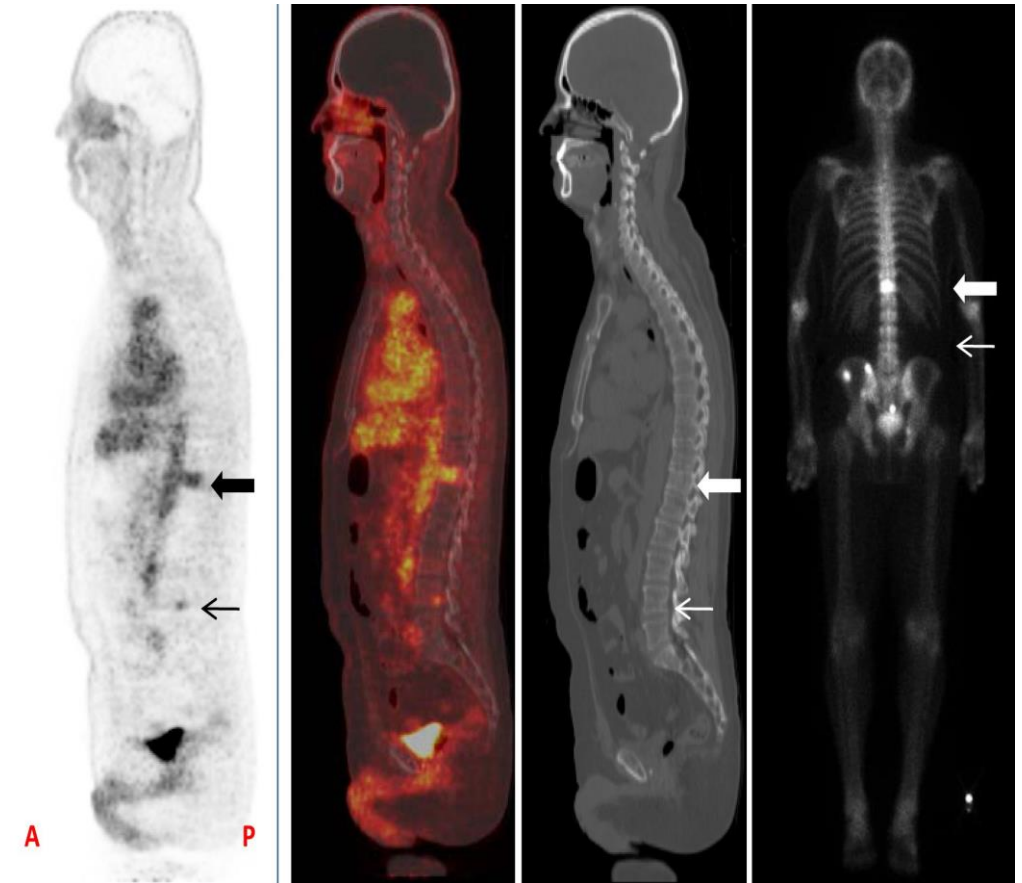
Bilan lésionnel

IRM



Bilan lésionnel

PET SCAN



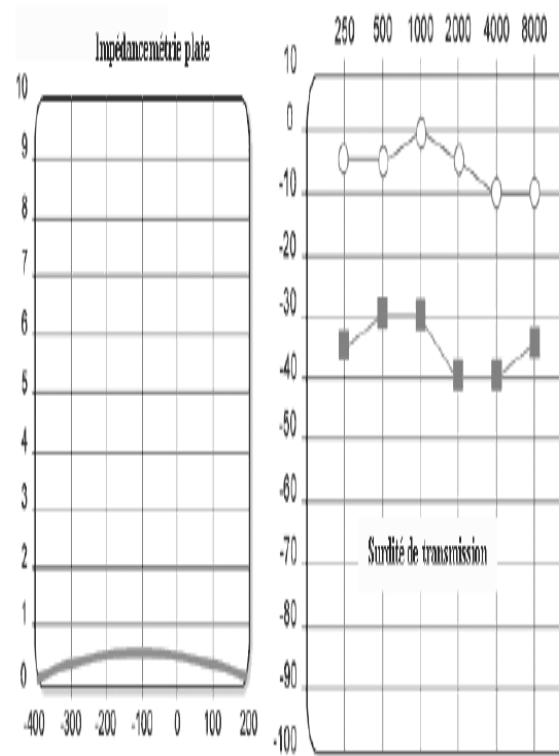
Bilan lésionnel

PANENDOSCOPIE



Bilan lésionnel

AUTRES



Classification (UICC2002)

I

- **T1**: tumeur limitée au cavum
- **T2**: atteinte de l'oropharynx ou des fosses nasales

T2a: sans extension parapharyngée

T2b: avec extension parapharyngée

- **T3**: envahissement des structures osseuses de la BDC ou des sinus
- **T4**: envahissement des structures endocrâniennes et/ou des nerfs crâniens, de la fosse infratemporale, de l'hypopharynx ou de l'orbite

Classification

N

N0: pas d'envahissement ganglionnaire

N1: ADP homolatérales de moins de 6cm

N2: ADP bilatérales de moins de 6 cm

N3: ADP de plus de 6 cm ou ADP sus claviculaire

N3a: ADP de plus de 6 cm

N3b: ADP sus claviculaire

M

M0: pas de métas

M1: présence de métas

Classification TNM 7^{ème} édition

T1	tumeur limitée au cavum
T2	T2a: atteinte de l'oropharynx ou des fosses nasales sans extension parapharyngée
	T2b: atteinte de l'oropharynx ou des fosses nasales avec extension parapharyngée
T3	envahissement des structures osseuses de la BDC ou des sinus
T4	envahissement des structures endo-crâniennes et/ou des nerfs crâniens, de la fosse infratemporale, de l'hypopharynx ou de l'orbite

Classification TNM 7^{ème} édition

N0	pas d'envahissement ganglionnaire
N1	ADP homolatérales de moins de 6cm
N2	ADP bilatérales de moins de 6 cm
N3	N3a: ADP de plus de 6 cm
	N3b: ADP sus claviculaire

Classification TNM 7^{ème} édition

M0	pas de métas
M1	présence de métas

Classification TNM 8^{ème} édition

- 2 changements +++
- Espace masticateur était considéré comme synonyme de la fosse infra temporale ??
- Certains T4 sont devenus T2 ??
- Pour les adénopathies:
le creux sus claviculaire a été remplacé par le rebord inférieur du cartilage cricoïde

Classification TNM 8^{ème} édition

T1	Tumeur confinée au nasopharynx ou s'étendant à l'oropharynx et/ou à la cavité nasale sans extension parapharyngée
T2	Extension parapharyngée et ou infiltration des muscles ptérygoidiens médial et ou latéral, et ou des muscles prévertébraux
T3	Envahissement des structures osseuses de la base du crâne, des sinus paranasaux, des vertèbres cervicales et ou des apophyses ptérygoidiens
T4	Extension intracrânienne et ou atteinte des nerfs crâniens de l'hypopharynx, de l'orbite, de la glande parotide et ou infiltration vers la surface latérale du muscle ptérygoïdien latéral

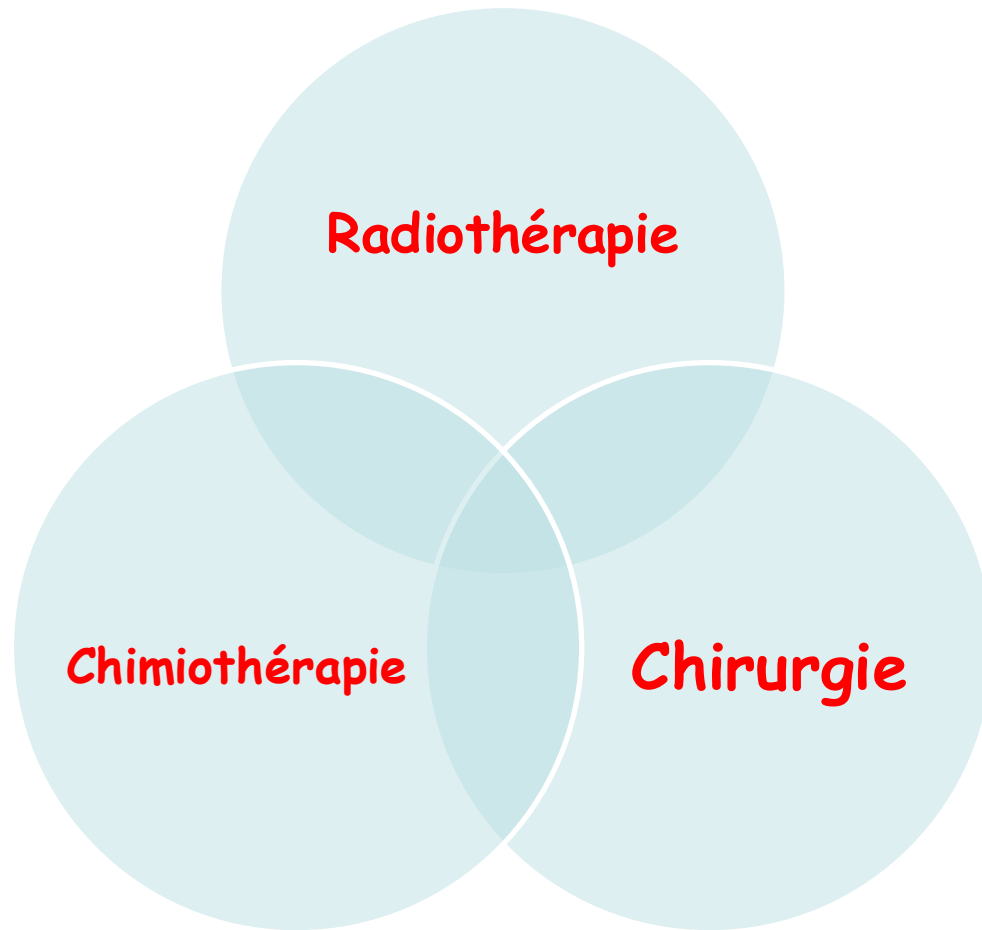
Classification TNM 8^{ème} édition

Nx	Envahissement ganglionnaire non évalué
N0	Pas d'atteinte des ganglions lymphatiques régionaux
N1	ADP unilatérale et ou bilatérale retro pharyngées, de moins de 6 cm et au -dessus du rebord inférieur du cartilage cricoïde
N2	ADP bilatérales $\leq$ 6cm, au dessus du rebord inférieur du cartilage cricoïde
N3	ADP $>$ 6cm et ou extension jusqu'à la clavicule

Classification TNM 8^{ème} édition

M0	pas de métas
M1	présence de métas

Traitement



Traitement

Buts:

- Éradiquer la tumeur
- Éviter les complications du traitement
- Éviter les récives
- Améliorer la survie et la qualité de vie

Traitement

Moyens:

- Radiothérapie
- Chimiothérapie
- Chirurgie ganglionnaire ou des Séquelles

Traitement

Moyens:

Radiothérapie

- Base du traitement
- Tumeur+ ganglions+ BDC
- Cobaltothérapie de 70gy
- 5j/7
- 6-7 semaines
- Limitée par les orbites latéralement, le cerveau en haut, la moelle en arrière

Radiothérapie

- Gold standard
- Déroulement
 - ✓ Cobaltothérapie de 70gy
 - ✓ 5j/7
 - ✓ 6-7 semaines



Radiothérapie



Radiothérapie

Site

- Tumeur
- Aires ganglionnaires

Technique

- Radiothérapie par modulation d'intensité
- Radiothérapie conformationnelle

Traitement

Moyens

Radiothérapie

Nouveautés

Radiothérapie par modulation d'intensité

Radiochirurgie: Radiothérapie interstitielle

Curiothérapie

Traitement

Moyens:

Chimiothérapie

- 5FU, Cisplatine
- Adriamycine, Bléomycine
- Concomitante ou néo-adjuvante
- Meilleur contrôle de la maladie
- Effet **potentialisateur** de la radiothérapie

Chimiothérapie

- **Protocole TPF**

- Taxotère J1 : 75 mg/m²
- Cisplatine J1 : 75 mg/m²
- 5-FU de J1 à J5 : 750 mg/m²/J



- **Protocole Cisplatine-5FU**

Cisplatine J1 : 100 mg/m² ou

Cisplatine fractionné 20 mg/m² J1 à J5

5-FU 1000 mg/m²/J de J1 à J5

Traitement

Moyens:

La chirurgie

- Non envisageable
- *Sauf en cas de reliquat ganglionnaire cervical post-radiothérapie*
- Evidement celluloganglionnaire latéro-cervical postérieur

Chirurgie

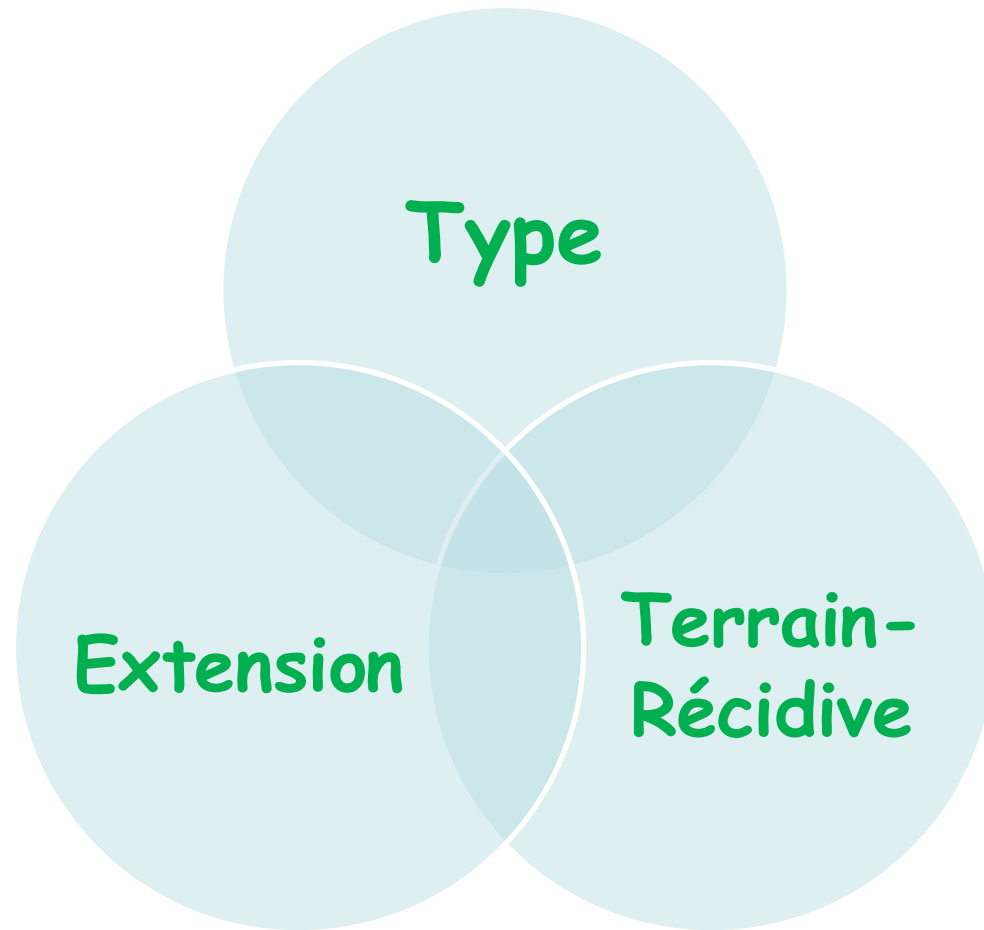
Tumeur



Aire
ganglionnaire



Indications



Traitement

Indications

Fonction du type histologique

Carcinome indifférencié (UCNT)

- Radio-chimiothérapie concomitante
- Chirurgie en cas de reliquat ganglionnaire après 3 mois.

CE différencié

- Radio-chimiothérapie concomitante suivie de chirurgie ganglionnaire si ADP dépasse 3 cm (N2N3)

Traitement

Indications

Fonction du type histologique

Chez l'enfant

Chimiothérapie pour diminuer les doses de radiothérapie sur la BDC

Lymphome

Chimio et/ou radiothérapie après bilan d'extension complet

Traitement

Indications

En fonction de la classification TNM

T1T2N0 Radiothérapie classique ou conformationnelle
Curiethérapie endocavitaire (à évaluer)

T1T2N1 Chimio néo-adjuvante et Radiothérapie

T3T4N0 Radiothérapie et Chimiothérapie
concomittante

N1N2N3

T4 avec signes neurologiques: chimio néo-adjuvante puis
Radiothérapie et Chimiothérapie concomittante

Maladie métastatique: Chimiothérapie (3-6 cures)
puis Radiothérapie

Complications

De la radiothérapie

- Cutanées: radiodermite
- Muqueuses: radiomucites
- Osseuses: ostéoradionécrose
- Dentaires
- Atrésies choanales post-radiothérapeutiques

De la chimiothérapie

- Hématologiques
- Cardiaques
- Métaboliques

Complications

Prévention des complications

- Soins dentaires préalables
- Gouttières fluorées
- Surveillance par hémogrammes
- Radiothérapie conformationnelle par modulation d'intensité

Surveillance

- Clinique: tous les 3 mois puis 1/an
- Endoscopie nasale: 1 mois/3mois puis /6mois
- IRM:1/an
- Radiographie pulmonaire: /an
- Surveillance endocrinienne: /an
- Surveillance dentaire: /an

- Survie: 30-50% à 5 ans tous stades confondus

Conclusion

- Maghreb: zone d'endémie
- UCNT: le plus fréquent
- Diagnostic histologique
- IRM: bilan d'extension
- Radiothérapie: base du traitement
- Avenir:

progrès des nouvelles techniques Radiothérapie

Vaccin anti-EBV?

Campagnes de dépistage

Conclusion



- *Le cancer du cavum : souvent un carcinome indifférencié*
- *tout âge: notamment chez le sujet jeune*
- *Son épidémiologie est originale par ses facteurs géographiques et viraux.*
- *Signes d'appel trompeurs (signes d'emprunt)*
- *L'examen du rhinopharynx en endoscopie doit être systématique :*

Dysfonctionnement tubaire chez l'adulte, d'autant qu'il est unilatéral

Paralysie du VI isolée

Adénopathie cervicale sans étiologie retrouvée